

SEPSE — BUNDLE 1H E ANTIBIÓTICO

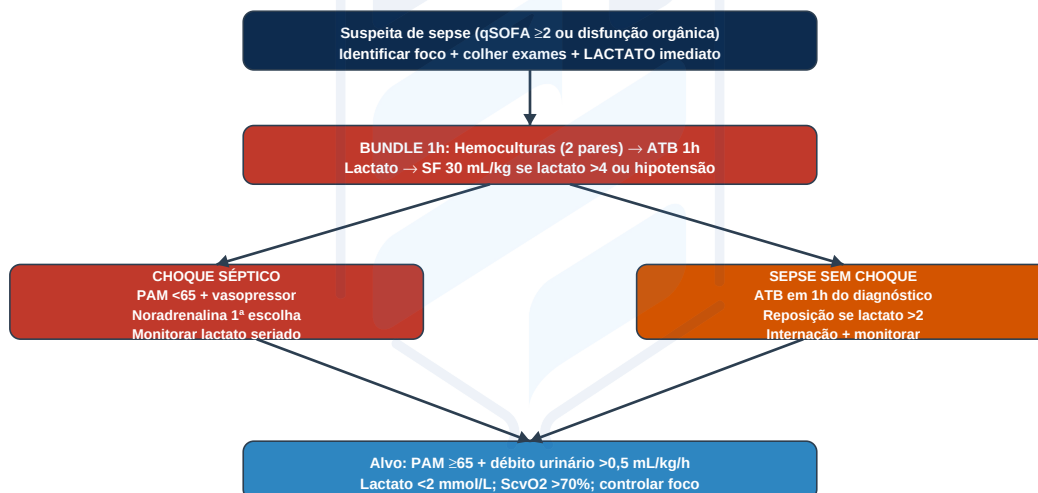
DEFINIÇÃO — SEPSIS-3 (2016)

CRITÉRIOS ATUAIS

- Sepse: disfunção orgânica ameaçadora à vida causada por resposta desregulada à infecção (SOFA ≥ 2 pontos)
- Choque séptico: sepse + vasopressor para PAM ≥ 65 + lactato > 2 mmol/L (18 mg/dL) após reposição volêmica
- SOFA ≥ 2 : PaO₂/FiO₂, bilirrubina, plaquetas, escala de Glasgow, creatinina, PAM
- qSOFA (triagem): FR ≥ 22 , Glasgow ≤ 13 , PAS ≤ 100 — ≥ 2 = suspeita de sepse (alta sensibilidade)
- Mortalidade: sepse 10-20%, choque séptico 30-50%

BUNDLE 1 HORA — SEP-1

SEPSE — AGIR EM 1 HORA



ANTIBIOTICOTERAPIA EMPÍRICA POR FOCO

Foco	ATB empírico preferido	Cobertura-alvo
Pneumonia (PAC)	Ampicilina-sulbactam + azitromicina OU ceftriaxona + azitromicina	S. pneumoniae, H. influenzae, atípicos
ITU urosepse	Ceftriaxona 1-2g IV	E. coli, Klebsiella (ESBL: meropeném)
Abdominal	Piperacilina-tazobactam 4,5g IV 8/8h	Gram-negativos + anaeróbios
Pele/partes moles	Oxacilina/Cefazolina ± Vancomicina se MRSA	S. aureus, Streptococcus
Nosocomial/UTI	Meropeném 1-2g IV 8/8h ± Vancomicina	Gram-negativos resistentes, MRSA
Foco desconhecido	Piperacilina-tazobactam OU meropeném + Vancomicina	Cobertura ampla empiricamente

VASOPRESSORES E INOTRÓPICOS

Droga	Dose inicial	Indicação
Noradrenalina (1ª escolha)	0,1-0,2 mcg/kg/min	Vasopressor de 1ª linha no choque séptico
Vasopressina	0,03-0,04 U/min fixo	Adjuvante da norad (poupar dose); PAM persistente baixa
Dobutamina	2,5-10 mcg/kg/min	Disfunção miocárdica (baixo DC + pressão adequada)
Adrenalina	0,1-0,5 mcg/kg/min	3ª linha; choque refratário a norad + vasopressina
Hidrocortisona	200 mg/dia IV contínuo	Choque refratário (≥ 2 vasopressores) — não de rotina

REPOSIÇÃO VOLÊMICA — COMO FAZER

FLUIDOS: QUANTO E QUANDO PARAR

- Bolus inicial: SF 0,9% ou Ringer lactato 30 mL/kg em 3h se lactato >4 ou hipotensão
- Avaliação dinâmica de responsividade: elevação passiva de membros (EPC) ou variação de PP ($>13\%$)
- Não dar cegamente além do inicial — monitorar sinais de sobrecarga (crepitações, B3, PVC elevada)
- Alvo: PAM ≥ 65 , débito urinário $>0,5$ mL/kg/h, melhora do lactato (clearance $\geq 10\%/2h$)
- Albumina 4%: adjuvante em pacientes que necessitem $>3L$ na fase de ressuscitação (evidência moderada)
- Evitar amido (HES): associado a LRA e mortalidade — contraindicado em sepse

CONTROLE DO FOCO E SUPORTE

Controle de Foco (essencial!)

- Identificar e drenar foco DENTRO DE 6-12h
- Abscesso: drenagem percutânea ou cirúrgica
- Colangite: CPRE + drenagem biliar urgente
- Peritonite: cirurgia dentro de 12h
- CVC infectado: remover o cateter
- Fascite necrotizante: desbridamento emergencial

Suporte Orgânico

- Glicemia: manter 140-180 mg/dL (insulina se >180)
- Transfusão: Hb alvo ≥ 7 g/dL (≥ 9 se IC/isquemia)
- Plaquetas: transfundir se $<10k$; cirurgia $<50k$
- VNI / VM: SARA, hipoxemia refratária
- TVP profilaxia: heparina SC (exceto sangramento)
- Profilaxia de úlcera: IBP se em VM ou coagulopatia

BUNDLE 1 HORA — CHECKLIST COMPLETO

AGIR EM 60 MINUTOS

- ☐ Lactato sérico: colher imediatamente (>4 = choque críptico / ressuscitação agressiva)
- ☐ Hemoculturas: 2 pares de sítios diferentes ANTES do antibiótico
- ☐ Antibiótico de amplo espectro: administrar em até 1h do diagnóstico
- ☐ Fluidos IV: iniciar SF/RL 30 mL/kg se PAS <90 ou lactato >4
- ☐ Vasopressores: se hipotensão persistente após fluidos $\rightarrow$ noradrenalina
- ☐ Lactato seriado a cada 2h: alvo <2 mmol/L (clearance $\geq 10\%$ = boa resposta)
- ☐ Identificar e tratar foco em 6-12h: drenagem, cirurgia, remoção de dispositivo

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Segundo Sepsis-3, o que define CHOQUE SÉPTICO?

- A) Febre $> 38,5^{\circ}\text{C}$ + leucocitose + hipotensão
- B) Sepse + necessidade de vasopressor para $\text{PAM} \geq 65 \text{ mmHg}$ + lactato $> 2 \text{ mmol/L}$
- C) Sepse + lactato $> 4 \text{ mmol/L}$ independentemente da PA
- D) Sepse + PCR elevada + 2 critérios de SIRS
- E) Infecção documentada + choque circulatório

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o vasopressor de PRIMEIRA LINHA no choque séptico?

- A) Dopamina em dose vasopressora
- B) Adrenalina
- C) Noradrenalina
- D) Dobutamina
- E) Vasopressina isolada

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Um paciente com sepse e choque tem lactato de 6 mmol/L . Qual é o principal alvo de tratamento nas primeiras 6 horas?

- A) Normalizar temperatura corporal com antitérmicos
- B) Clearance de lactato $\geq 10\%$ a cada 2h + $\text{PAM} \geq 65$ + débito urinário $> 0,5 \text{ mL/kg/h}$
- C) Manter FC $< 100 \text{ bpm}$ com betabloqueador
- D) Administrar corticoide sistêmico imediatamente
- E) Aguardar hemoculturas antes de qualquer antibiótico

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Em paciente com choque séptico de foco abdominal (abscesso hepático), qual é o prazo máximo preconizado para controle do foco?

- A) 72 horas após estabilização clínica
- B) 6-12 horas do diagnóstico
- C) Aguardar ATB por 5 dias antes de drenar
- D) Apenas se não houver melhora em 48h
- E) Não há indicação cirúrgica sem falência orgânica

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Por que os coloides do tipo amido (HES) são contraindicados na sepse?

- A) Causam hiperpotassemia grave
- B) São contraindicados por aumentar risco de LRA e mortalidade em sepse
- C) Causam hipercoagulabilidade
- D) Não são contraindicados; a evidência é favorável ao HES
- E) São contraindicados apenas em crianças

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Sepsis-3 define choque séptico como: sepse + vasopressor necessário para PAM ≥ 65 + lactato > 2 mmol/L após ressuscitação volêmica adequada. Não usa mais critérios de SIRS. Mortalidade 30-50%.

QUESTÃO 2 → Resposta: C

Noradrenalina é o vasopressor de 1ª linha no choque séptico (Surviving Sepsis Campaign). Possui ação α -adrenérgica predominante (vasoconstritora) com menor taquicardia que dopamina. Dopamina aumenta mortalidade em subgrupos.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Alvos da ressuscitação: clearance de lactato $\geq 10\%/2h$ (SVRO2 $> 70\%$), PAM ≥ 65 , débito urinário $> 0,5$ mL/kg/h. Lactato persistentemente elevado = má perfusão tissular. Reduzir lactato em 10% nas primeiras 2h é marcador de resposta.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Controle de foco em 6-12h é fundamental — antibiótico sem drenagem do foco falha. Abscesso: drenagem percutânea ou cirúrgica imediata. Colangite: CPRE urgente. Peritonite: cirurgia em $< 12h$.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

HES (hidroxietilamido) está contraindicado em sepse por aumentar risco de LRA e mortalidade (estudos 6S e CHEST). Soluções isotônicas (SF 0,9%, Ringer lactato) são preferidas. Albumina 4% pode ser adjuvante.

SM24
Suporte ao Plantão Médico